SDD 304 Sujet n°1

Spécialité : Endocrinologie, Gynécologie

Date : 11/11/2023
Auteur : SAMANNI Léa (DES Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition, ECN 2023)
Relecteur(s) : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie Grenoble - ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaines d'apprentissage secondaire	Annonce et information du patient
Item(s) en lien avec la station	Item 255 - Diabète gestationnel
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 304 - Dépistage du diabète gestationnel
Matériel nécessaire à la station	1 bureau, 2 chaises
Contexte de la station	Vous êtes médecin généraliste et vous recevez en consultation Mme. SAVALI, 38 ans, enceinte de 12 semaines d'aménorrhée.

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste en cabinet.
Vous recevez la patiente Mme. SAVALI âgée de 38 ans. Celle-ci est enceinte de 12 semaines d'aménorrhée.
Vous lui avez déjà prescrit tous les examens complémentaires obligatoires à réaliser lors de la première consultation de suivi de grossesse.
Elle vous rapporte les résultats de ces derniers qui sont tous normaux et rassurants.

Elle vous montre fièrement sa glycémie à jeûn, qui est à 0, 85 g/L.
Elle se demande d'ailleurs pourquoi vous lui avez prescrit cette glycémie, elle vous l'a déjà dit : elle n'a pas de diabète !

Consignes :
Vous avez 8 minutes :

- Interroger la patiente sur ses facteurs de risque de diabète gestationnel puis lui expliquer pourquoi la glycémie a été prescrite dans son cas

- Expliquer à la patiente les risques maternels etfoetaux associés au diabète gestationnel.

- Décider de la suite de la stratégie de dépistage du diabète gestationnel. Expliquer simplement à la patiente en quoi cela consiste.

Vous ne devez pas :

- Examiner la patiente
- Réaliser un interrogatoire générale
- Rédiger d'ordonnance

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Grille d'évaluation basée sur le collège de gynécologie

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	L'étudiant(e) demande à la patiente son IMC OU les éléments de mesure permettant de le calculer (poids ET taille) *La patiente connaît son IMC si l'étudiant le lui demande !* *On accorde le point si seul l'IMC est demandé : le calcul n'est pas attendu !*	1 pt	☐
2.	L'étudiant(e) demande à la patiente si elle a des antécédents personnels de diabète gestationnel.	1pt	☐
3.	L'étudiant(e) demande à la patiente si elle a des antécédents de macrosomie foetale (poids de naissance > 4 kg).	1pt	☐
4.	L'étudiant demande à la patiente si elle a des antécédents familiaux au premier degré (père, frère, mère, sœur) de diabète (de type 2). *(On accorde le point si l'étudiant ne précise pas type 1 ou type 2…parce que beaucoup de patients ne savent pas faire la différence…).*	1pt	☐
5.	L'étudiant explique à la patiente qu'au vu de son âge ET de son IMC, elle est à risque de développer un diabète gestationnel. *Si l'étudiant(e) ne mentionne que l'âge OU que l'IMC, on n'accorde pas le point.*	1pt	☐
6.	L'étudiant explique à la patiente les risques maternels associés au diabète gestationnel au cours de la grossesse et de l'accouchement *(1 point accordé si les deux éléments sont cités par l'étudiant)* : • Pré-éclampsie et/ou HTA gravidique • Césarienne *Point accordé pour pré-éclampsie seulement si l'étudiant explique la pré-éclampsie (HTA durant la grossesse avec protéines dans les urines ou autre explication validée par l'examinateur)*	1 pt	☐
7.	L'étudiant explique à la patiente les risques maternels associés au diabète gestationnel au DÉCOURS de la grossesse (*1 point accordé si au moins 2 des 3 éléments suivants*) : • Augmentation du risque cardio-vasculaire	1 pt	☐

	• Risque ultérieur de développer un diabète de type 2 • Syndrome métabolique		
8.	L'étudiant explique à la patiente les risques foetaux associés au diabète gestationnel *(1 point accordé SI les deux éléments sont présents)* : • Macrosomie foetale • Hypoglycémie néonatale sévère	1 pt	☐
9.	Il explique aussi le risque pour le foetus de développer ultérieurement *(1 point accordé si au moins 2 des 3 éléments sont cités par l'étudiant)* : • Obésité • HTA • Diabète de type 2	1 pt	☐
10.	Etudiant explique à la patiente qu'il faudrait faire une hyperglycémie provoquée par voie orale, à réaliser entre 24 et 28 SA. *(les valeurs seuil diagnostiques ne sont pas attendues)*	1 pt	☐
11.	Explications simples de l'étudiant(e) sur le test d'hyperglycémie provoquée par voie orale : première prise de sang à jeûn, puis ingestion de 75g de glucose, et mesure de la glycémie à 1h et à 2h.	1 pt	☐
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)			
1.	**3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

TOTAL (/12 points)	**X points**

<u>Éléments de rétroaction :</u>
Station uniquement axée diabète gestationnel ! Ne pas s'éparpiller sur les autres examens réalisés au premier trimestre. J'espère avoir été assez claire dans les informations données et les consignes !

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Mme. SAVALI, 34 ans. Enceinte de 12 semaines d'aménorrhée.
Suivi de grossesse débuté par le médecin traitant qui lui a prescrit tous les examens complémentaires obligatoires du premier trimestre dont une glycémie veineuse à jeûn dans le cadre du dépistage du diabète gestationnel.

Plan de la station ECOS :

Patiente assise face à l'étudiant.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

"Bon je vous l'avais dit docteur : je n'ai pas de diabète moi ! Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez prescrit cette glycémie d'ailleurs".

Identité du patient :

Mme SAVALI Justine, **38 ans**
Mesure 1, 60m et pèse 73 kg, **IMC à 28, 5**

Mode de vie :

Travaille comptable dans une entreprise de logistique.
Elle aime le cinéma et la pâtisserie.
Vit avec son conjoint.
Il s'agit de sa première grossesse, elle est G1P0.
Elle n'a jamais fumé et ne consomme que très rarement de l'alcool (et encore moins depuis qu'elle est enceinte).
Elle n'a pas d'allergies et ne prend pas de traitement.

Comportement global :

Patiente un peu "rebelle", qui ne comprend pas pourquoi on lui parle de diabète et qu'il faudra motiver pour faire l'HGPO du deuxième trimestre !

Antécédents personnels :

- Premières règles à 15 ans, cycles réguliers avant la mise sous pilule. Arrêt de la pilule il y a 6 mois dans ce contexte de désir de grossesse.
- Il s'agit de sa première grossesse (G1P0)
- Cholécystectomie il y a 8 ans
- Appendicectomie il y a 20 ans
- Aucun ATCD cardiovasculaire

Antécédents familiaux :

- HTA chez la père

Médicaments :

Aucun

Symptômes positifs :

La patiente est asymptomatique.

- Si l'étudiant(e) demande à la patiente son poids et sa taille, elle répond : "Je mesure 1m60, je crois que je pèse 73kg, et mon IMC est de 28, c'est vous qui l'avez calculé docteur la dernière fois".
- Si l'étudiant(e) demande à la patiente si elle a des antécédents personnels de diabète gestationnel et/ou de macrosomie foetale, elle

répond : “C’est ma première grossesse docteur”

- Si l’étudiant(e) demande à la patiente si elle a des antécédents familiaux de diabète (type 1 ou 2), elle répond : “Personne n’a de diabète dans ma famille, je ne vois pas pourquoi j’en aurais”.
- Si l’étudiant(e) demande à la patiente ses antécédents personnels autres, elle répond : “Oh pas grand chose, une opération de la vésicule biliaire et les amygdales quand j’étais petite”.
- Si l’étudiant(e) demande à la patiente ses antécédents familiaux autres, elle répond : “Mon père, il a de la tension je crois”.
- La patiente peut questionner l’étudiant sur la signification de certains termes médicaux tels que : macrosomie foetale, syndrome métabolique, pré-éclampsie afin d’obtenir des mots et des explications simples de l’étudiant et l’amener à développer.

Constantes :

FC à 85 bpm, TA à 130/76 mmHg
Patiente apyrétique

Donnée complémentaire :

On peut éventuellement laisser une feuille avec le résultat de la glycémie à jeûn du premier trimestre prescrite à la patiente.
Ne PAS donner tous les résultats des autres examens prescrits : on axe la station uniquement sur le diabète gestationnel.

Questions de relance :

Peut-être qu’on peut aider l’étudiant(e) sur la proposition de l’HGPO à la 5ème minute par exemple ? La patiente pourrait dire “Donc si j’ai bien compris ma glycémie est normale sur la prise de sang, est-ce que je dois faire d’autres tests maintenant ?”

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Patiente assise face à l'étudiant. Un bureau entre les deux. Valeur de glycémie à jeûn prescrite au premier trimestre sur une feuille bien mise en évidence.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours